

Medicalização e Patologização da Infância

Apostila de leitura — Grupo 3 (Kaio, Ester, Antônia, Flávia) | Infância

Psicologia do Desenvolvimento Humano — 1º Semestre | Trabalho Avaliativo, 13/10

0. Como usar esta apostila

Esta apostila sintetiza 18 fontes reunidas na pasta de Fundamentação Teórica do grupo. Toda afirmação relevante traz, entre parênteses, a indicação (Fonte: nome do PDF, p. X). A lista completa de referências está ao final. O objetivo do texto, conforme pede o roteiro do trabalho, não é descrever 'o que é' a medicalização, mas analisar por que ela acontece, que condições sociais e relacionais a sustentam, e que efeitos produz no desenvolvimento humano.

1. Apresentação da problemática

O que é medicalização e patologização da infância

Medicalização é o processo pelo qual questões da vida social — complexas, multifatoriais, marcadas pela cultura e pelo tempo histórico — são reduzidas a uma racionalidade que vincula a dificuldade de adaptação a normas sociais a determinismos orgânicos, que se expressariam no adoecimento do indivíduo (Fonte: CFP_CartilhaMedicalizacao_web-16.06.15.pdf, p. 11).

Patologizar, por sua vez, é tratar como doença, transtorno ou distúrbio de cunho pessoal ou familiar aquilo que é, na origem, uma questão de política pública, de cultura ou de organização social (Fonte: 03_Infancia_Patologizacao_Nao_Aprendizagem.pdf, p. 3, citando Souza, 2016). Os dois processos costumam andar juntos: medicalizar um fenômeno teve, tradicionalmente, o sentido de reduzir problemas sócio-políticos a questões individuais, e essa redução tem por consequência patologizá-lo (Fonte: 02_Medicalizacao_Patologizacao_Educacao.pdf, p. 2, citando Guarido, 2011).

Uma imagem resume bem a inversão de lógica que caracteriza o fenômeno: em vez de se fabricarem remédios para doenças já existentes, fabricam-se doenças para remédios, com vistas ao aquecimento de um mercado farmacêutico (Fonte: CFP_CartilhaMedicalizacao_web-16.06.15.pdf, p. 12).

Como se manifesta hoje

No contexto escolar brasileiro, a manifestação mais visível é o encaminhamento maciço de crianças com dificuldades de aprendizagem ou de comportamento para diagnóstico e tratamento médico-psiquiátrico: nunca antes as escolas encaminharam tantos estudantes com queixa escolar para serviços de saúde (Fonte: 01_Dialogos_Medicalizacao.pdf, p. 3). Dificuldades no processo de ensinar e aprender, que poderiam ser resolvidas com intervenção pedagógica, passam a ser caracterizadas como transtornos neurológicos que exigem intervenção médica e medicamentosa (Fonte: 01_Dialogos_Medicalizacao.pdf, p. 3).

Os números tornam essa manifestação concreta. O Brasil tornou-se o segundo maior mercado mundial de metilfenidato (Ritalina®, Concerta®), com cerca de 2.000.000 de caixas vendidas em 2010 (Fonte: Resoluo177Conanda.pdf, p. 1) — alta de 775% no consumo entre 2003 e 2012, segundo o Instituto de Medicina Social da UERJ (Fonte: Resoluo177Conanda.pdf, p. 2). Em uma década, as vendas saltaram de 70 mil para dois milhões de caixas por ano, tornando o país o segundo maior consumidor dessa droga no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos (Fonte: Caderno_AF.pdf, p. 5). Em paralelo, o DSM — manual diagnóstico da psiquiatria norte-americana — passou de 106 categorias de transtorno em 1952 para cerca de 300 em 2013 (Fonte:

03_Infancia_Patologizacao_Nao_Aprendizagem.pdf, p. 3) e para aproximadamente 500 na edição revisada de 2023 (Fonte: DSM E TRANSTORNOS ASSOCIADOS À INFÂNCIA A CLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICA PSQUIÁTRICA EM DISCUSSÃO.pdf, p. 2-3, 11).

Por que é relevante para a fase da infância

A infância é o alvo privilegiado desse processo porque é justamente o período em que o desenvolvimento humano é mais plástico, mais dependente da mediação de adultos e instituições, e mais sujeito à avaliação permanente por parte da escola e da família. É também o momento em

que a criança menos pode recusar, questionar ou renegociar um diagnóstico que lhe é atribuído por adultos — pais, professores, médicos — que falam por ela. Como mostra a Resolução nº 177/2015 do CONANDA, a infância tem direito à proteção integral e a não ser submetida à excessiva medicalização, definida como "a redução inadequada de questões de aprendizagem, comportamento e disciplina a patologias" (Fonte: Resolucao177Conanda.pdf, p. 2, Art. 1º, parágrafo único) — o próprio fato de haver uma resolução federal específica sobre o tema evidencia a magnitude do problema na infância brasileira contemporânea.

2. Glossário — significados das palavras do tema

Medicalização

Processo que transforma, artificialmente, questões não médicas (sociais, políticas, pedagógicas, afetivas) em problemas médicos (Fonte: Caderno_AF.pdf, p. 13, Manifesto do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade). O termo foi proposto por Irving Zola em 1972 para descrever o aumento da jurisdição da profissão médica sobre novos domínios da vida (Fonte: 07_Medicalizacao_Infancias_Cuidados_Medicamentos.pdf, p. 452).

Patologização

Ato de atribuir a um fenômeno o estatuto de doença/transtorno. Enquanto a medicalização é o processo mais amplo de levar uma questão para o campo médico, a patologização é seu efeito mais direto: tornar patológico (fora da norma, carente de tratamento) algo que antes era lido como parte da diversidade humana ou como produto de condições sociais (Fonte: 02_Medicalizacao_Patologizacao_Educacao.pdf, p. 2).

Biopoder e biopolítica (Michel Foucault)

Biopoder é a tecnologia de poder que incide sobre o corpo individual, disciplinando-o, tornando-o dócil e produtivo; biopolítica é a tecnologia que incide sobre o "corpo-espécie" — a população —, regulando natalidade, mortalidade, saúde e longevidade (Fonte: 01_Dialogos_Medicalizacao.pdf, p. 5; Fonte: 15_Foucault_Illich_Biopolitica.pdf, p. 100). "Uma sociedade normalizadora é o efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada na vida" (Foucault, citado em Fonte: 15_Foucault_Illich_Biopolitica.pdf, p. 100-101).

Iatrogênese (Ivan Illich)

Dano ou doença causada pela própria ação médica. Illich distingue três níveis: iatrogênese clínica (efeitos adversos diretos do tratamento), social (a medicalização da vida como efeito social) e cultural/estrutural (perda da capacidade autônoma das pessoas de lidar com a dor, a doença e a morte sem mediação de especialistas) (Fonte: Ivan Illich da expropriação à desmedicalização da saúde.pdf, p. 1188; Fonte: 13_Bases_Teoricas_Medicalizacao_Tese_USP.pdf, p. 61-64).

TDAH, dislexia e Transtornos Funcionais Específicos (TFE)

O TDAH é descrito pela psiquiatria organicista como "transtorno neurobiológico, de causas genéticas... caracterizado por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade" (Fonte: 09_Medicalizacao_Educacao_Implicacoes.pdf, p. 745). A literatura crítica contesta essa definição: os critérios diagnósticos ("perde as coisas", "é distraído", "se remexe na carteira") decorrem de aprendizagens sociais e podem mudar conforme o contexto — a mesma criança pode se agitar na aula de um professor e ficar atenta na de outro (Fonte: 09_Medicalizacao_Educacao_Implicacoes.pdf, p. 748). TFE é a categoria guarda-chuva que reúne dislexia, disortografia, discalculia e TDAH como supostas "disfunções neurológicas" do aprender (Fonte: 09_Medicalizacao_Educacao_Implicacoes.pdf, p. 745).

Queixa escolar e fracasso escolar

Fracasso escolar é uma expressão institucionalizada que opera produzindo saber: antes, o aluno fracassado era aquele com "desinteresse" ou "falta de educação"; hoje é o aluno com alguma disfunção cerebral presumida (Fonte: 02_Medicalizacao_Patologizacao_Educacao.pdf, p. 3, citando Luengo, 2010). Considerar que a causa da queixa escolar está no psiquismo ou no intelecto da criança exime o sistema escolar de qualquer participação na produção dessa dificuldade (Fonte: 02_Medicalizacao_Patologizacao_Educacao.pdf, p. 2, citando Souza, 2007).

Desmedicalização e despatologização

Movimento, acadêmico e social, de resistência à medicalização — presente em hashtags, fóruns e publicações científicas (Fonte: 05_Mapeando_Controversias.pdf, p. 5) — que propõe devolver ao campo social, pedagógico e cultural problemas hoje tratados como biológicos. Illich propunha a "desprofissionalização" da medicina como caminho para a desmedicalização (Fonte: 13_Bases_Teoricas_Medicalizacao_Tese_USP.pdf, p. 69, 72-73).

Discurso competente e normal/patológico

Discurso competente é o discurso de quem detém saber institucionalmente reconhecido (o médico, o professor), que adquire o direito de falar e agir pelo outro, destituindo-o de sua condição de sujeito (Fonte: 09_Medicalizacao_Educacao_Implicacoes.pdf, p. 758, citando Chauí, 2014). Para Georges Canguilhem, um traço humano não é normal por ser frequente — é frequente por ser normal, ou seja, normativo dentro de um determinado modo de vida (Fonte: 09_Medicalizacao_Educacao_Implicacoes.pdf, p. 747).

3. Principais autores e referências teóricas

Michel Foucault

Nunca usou a palavra "medicalização", mas descreveu, desde o fim do século XVIII, a constituição de uma medicina de higienização e disciplinarização dos corpos (Fonte: 01_Dialogos_Medicalizacao.pdf, p. 5). Em "Os anormais", mostra como a psiquiatria se tornou uma "medicina do não-patológico", abrangendo condutas desviantes para além da loucura clássica (Fonte: 08_Movimentos_Medicalizacao_Vida.pdf, p. 21), e como a família burguesa foi tornada "penetrável" ao poder médico: "faz-se que ela fique penetrável por toda uma técnica de poder, de que a medicina e os médicos são transmissores junto às famílias" (Fonte: 08_Movimentos_Medicalizacao_Vida.pdf, p. 23, citando Foucault, 2010, p. 222).

Ivan Illich

Crítico radical da sociedade industrial; via a medicina institucionalizada como uma "elite" que ameaça a saúde ao colonizar a vida e monopolizar o conhecimento sobre o corpo (Fonte: Ivan Illich da expropriação à desmedicalização da saúde.pdf, p. 1187). Para ele, a melhoria histórica da expectativa de vida se deveu a condições de nutrição e moradia, não à ação médica — e a medicina de ponta gerou, em troca, a própria doença iatrogênica (Fonte: Ivan Illich da expropriação à desmedicalização da saúde.pdf, p. 1189-1190). Morreu em 2002 recusando tratamento médico, por coerência com suas próprias ideias (Fonte: Ivan Illich da expropriação à desmedicalização da saúde.pdf, p. 1188-1189).

Peter Conrad e Irving Zola

Conrad mostra que a medicalização não é um imperialismo médico unidirecional: há uma interação social complexa, com múltiplos atores (indústria farmacêutica, associações de pais, legisladores), em que o próprio medicalizado é ativo (Fonte: 01_Dialogos_Medicalizacao.pdf, p. 6). Seu estudo de caso sobre a hipercinesia infantil (precursora do TDAH) mostra quatro consequências da medicalização de um comportamento: controle do especialista, controle social médico, individualização de um problema social e despolitização do desvio (Fonte: 13_Bases_Teoricas_Medicalizacao_Tese_USP.pdf, p. 75-85). Zola, por sua vez, descreve a medicina como novo "repositório da verdade", substituindo a religião e a lei na regulação social dos comportamentos (Fonte: 01_Dialogos_Medicalizacao.pdf, p. 6).

Maria Helena Souza Patto

Referência clássica da crítica brasileira à patologização do fracasso escolar associada a classe social. Mostrou que a ausência, nas classes populares, de hábitos e práticas das classes dominantes foi historicamente lida como "atraso cultural", deslocando-se depois para uma leitura organicista: "a inadequação da escola decorre muito mais de sua má qualidade... do que da suposição de que os alunos pobres não têm habilidades que, na realidade, muitas vezes possuem" (Fonte: 03_Infancia_Patologizacao_Nao_Aprendizagem.pdf, p. 2, citando Patto, 1990, p. 340).

Cecília Collares e Maria Aparecida Moysés

Autoras centrais da crítica brasileira à base orgânica atribuída a distúrbios de aprendizagem. Síntese de sua tese: "É crescente o deslocamento de problemas inerentes à vida para o campo médico, com a transformação de questões coletivas, de ordem social e política, em questões individuais, biológicas... Isentam-se de responsabilidades todas as instâncias de poder, em cujas entranhas são gerados e perpetuados tais problemas" (Fonte: 03_Infancia_Patologizacao_Nao_Aprendizagem.pdf, p. 3, citando Moysés e Collares, 2015, p. 80).

Lev Vigotski (psicologia histórico-cultural)

Base teórica central para situar a crítica dentro da própria Psicologia do Desenvolvimento: distingue Funções Psíquicas Elementares (de base biológica) de Funções Psíquicas Superiores — atenção voluntária, memória lógica, pensamento verbal —, que são desenvolvidas culturalmente, na relação com o outro e com os instrumentos criados historicamente e socialmente (Fonte:

04_Medicalizacao_Fracasso_Escolar.pdf, p. 6). Para Vigotski, "toda a aprendizagem só é possível na medida em que se baseia no próprio interesse da criança" (Fonte:

09_Medicalizacao_Educacao_Implicacoes.pdf, p. 752) — um contraponto direto à ideia de que a desatenção é, por definição, um déficit neurológico fixo.

Outros autores que aparecem nas fontes

Jacques Donzelot e Philippe Ariès (construção histórica da infância e da família medicalizada); Sandra Caponi e Luciana Caliman (biodiagnósticos, "cidadanias biológicas", crítica ao DSM-5 e à psiquiatria do desenvolvimento); Marisa Meira (a medicalização oculta condicionantes sociais, culturais, políticos e afetivos); Allen Frances, ex-coordenador do próprio DSM-IV, hoje crítico interno do sistema que ajudou a construir: "Transformamos problemas cotidianos em transtornos mentais" (Fonte: 02_Medicalizacao_Patologizacao_Educacao.pdf, p. 6); e D. W. Winnicott, cuja teoria do cuidado (holding, "mãe suficientemente boa") permite pensar o sofrimento infantil como efeito de falhas ambientais, não de disfunção cerebral (Fonte: 07_Medicalizacao_Infancias_Cuidados_Medicamentos.pdf, p. 454).

4. Relação com o desenvolvimento humano

O roteiro pede que o grupo explique quais processos e características do desenvolvimento estão envolvidos na problemática. A psicologia histórico-cultural de Vigotski oferece a chave teórica mais direta: o desenvolvimento infantil não é a simples maturação de um substrato biológico fixo, mas um processo em que funções psíquicas superiores — atenção voluntária, linguagem, memória lógica — só se formam na relação social, mediadas por adultos e por instrumentos culturais (Fonte: 04_Medicalizacao_Fracasso_Escolar.pdf, p. 6). Quando um comportamento infantil é lido diretamente como sintoma neurológico, sem investigar o contexto de interação em que ele ocorre, essa mediação social — motor do próprio desenvolvimento — é apagada da análise.

O caso de "Susi", documentado em entrevistas e pareceres escolares desde os 2 anos de idade, ilustra isso de forma concreta: diagnosticada com TDAH aos 6 anos e medicada desde então, a menina só avançou na leitura e na escrita no 3º ano, com uma professora mais acolhedora — ainda sob medicação. A melhora foi atribuída pelas próprias pesquisadoras a fatores afetivo-volitivos da relação pedagógica, e não ao diagnóstico ou ao remédio (Fonte:

09_Medicalizacao_Educacao_Implicacoes.pdf, p. 757). Isso evidencia que a qualidade do vínculo entre adulto e criança — elemento central de qualquer teoria do desenvolvimento centrada na interação social — tem peso explicativo maior do que a suposta disfunção biológica isolada.

Historicamente, a infância como fase do desenvolvimento também foi construída de modo distinto da atual: antes do século XVIII, a criança era vista como um "pequeno adulto" (Fonte:

08_Movimentos_Medicalizacao_Vida.pdf, p. 22, citando Ariès, 1978). A psiquiatrização da infância, posteriormente, nasceu não da "loucura" infantil, mas da categoria de "idiotia" —

lida à época não como doença, mas como "uma variação do processo de desenvolvimento, um estado que pertence à infância" (Fonte: 08_Movimentos_Medicalizacao_Vida.pdf, p. 24, citando Lobo, 2008, p. 372). Essa origem histórica mostra que a fronteira entre "desvio do desenvolvimento" e "doença" é uma construção social e institucional, não um dado biológico estável.

Do ponto de vista afetivo, a perspectiva winnicottiana permite pensar o sofrimento infantil

como efeito de rupturas no cuidado (holding) oferecido pelo ambiente, e não como disfunção localizada no cérebro da criança: "quando a criança é medicalizada, o cuidador não promove um enigma que permite o vir-a-ser infantil" (Fonte:

07_Medicalizacao_Infancias_Cuidados_Medicamentos.pdf, p. 454, citando Figueiredo, 2009). O brincar, atividade central do desenvolvimento infantil para Vigotski e para a psicanálise, também é afetado: a medicação estimulante "entorpece e indisponibiliza o sujeito para a interação", substituindo uma forma espontânea de elaboração de conflitos por uma solução química (Fonte: 05_Mapeando_Controversias.pdf, p. 10-11).

Por fim, há uma dimensão social e histórica mais ampla: mudanças na estrutura familiar contemporânea — entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho sem redistribuição equivalente do cuidado, inserção muito precoce das crianças em creches — produziriam "novas modalidades de subjetivação e de transtornos psíquicos" (Fonte: 07_Medicalizacao_Infancias_Cuidados_Medicamentos.pdf, p. 455, citando Birman, 2007). Entender a problemática exige, portanto, articular processos psicológicos individuais (vínculo, linguagem, brincar) a transformações sociais, culturais e econômicas mais amplas — exatamente o que a pergunta norteadora do trabalho pede que o grupo investigue.

5. Fundamentação teórica aprofundada

A fragilidade científica do DSM

Um pilar da fundamentação teórica da crítica é mostrar que o DSM não é um instrumento neutro de diagnóstico, mas um produto histórico e político. Um levantamento bibliográfico entre 2014 e 2016 encontrou 128 publicações favoráveis ao manual contra 122 publicações desfavoráveis — uma controvérsia equilibrada, não um consenso científico (Fonte:

02_Medicalizacao_Patologizacao_Educacao.pdf, p. 6). Cerca de 70% da força-tarefa que compôs o DSM-5 relatou ter relações financeiras com a indústria farmacêutica (Fonte: DSM E TRANSTORNOS ASSOCIADOS À INFÂNCIA A CLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICA PSIQUIÁTRICA EM DISCUSSÃO.pdf, p. 6, citando Cosgrove & Krinsky, 2012). O psiquiatra Joseph Biederman, responsável por boa parte da expansão do diagnóstico de bipolaridade infantil nos EUA (aumento de mais de 40 vezes em poucas décadas), era financiado pela Johnson & Johnson, fabricante do antipsicótico Risperdal (Fonte: DSM E TRANSTORNOS ASSOCIADOS À INFÂNCIA A CLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICA PSIQUIÁTRICA EM DISCUSSÃO.pdf, p. 6).

Mesmo os estudos de neuroimagem citados para sustentar uma base biológica do TDAH têm problemas metodológicos sérios: ao reanalisar o estudo mais citado da área (Castellanos et al., 2002), pesquisadores mostraram que os grupos comparados (medicados, não medicados e controle) não eram equivalentes em idade, e que a própria medicação estimulante — usada havia anos pelo grupo "medicado" — pode alterar a estrutura cerebral observada, invertendo a relação de causa e efeito (Fonte: 09_Medicalizacao_Educacao_Implicacoes.pdf, p. 746-747). O próprio DSM-5-TR reconhece hoje uma metanálise que não encontrou diferença de volume cerebral entre crianças com TDAH e controles (Fonte: DSM E TRANSTORNOS ASSOCIADOS À INFÂNCIA A CLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICA PSIQUIÁTRICA EM DISCUSSÃO.pdf, p. 10). As próprias estimativas de prevalência de TDAH no Brasil variam de 0,9% a 26,8%, segundo o Boletim de Farmacoepidemiologia da Anvisa (Fonte: Resoluo177Conanda.pdf, p. 2) — uma discrepância incompatível com um transtorno de base biológica bem definida.

A dimensão econômica: a indústria farmacêutica como ator estrutural

A indústria farmacêutica é a segunda em faturamento no mundo, atrás apenas da indústria bélica (Fonte: Caderno_AF.pdf, p. 5). Nos Estados Unidos, o mercado de psicoestimulantes pulou de 1,7 bilhão para 9 bilhões de dólares em uma década, acompanhando o salto nos diagnósticos de TDAH de 600 mil para 3,5 milhões a partir de 1990 (Fonte: DSM E TRANSTORNOS ASSOCIADOS À INFÂNCIA A CLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICA PSIQUIÁTRICA EM DISCUSSÃO.pdf, p. 9). No Brasil, um levantamento junto a municípios paulistas mostrou aumento de cerca de 1.284% na compra/dispensação de metilfenidato entre 2005 e 2011 (Fonte: Caderno_AF.pdf, p. 7-8). Entender esses números como fundamentação teórica, e não apenas como curiosidade estatística, é o que permite ao grupo

sustentar a tese foucaultiana e illichiana de que a medicina contemporânea está estruturalmente associada a interesses econômicos que extrapolam o cuidado clínico individual (Fonte:

13_Bases_Teoricas_Medicalizacao_Tese_USP.pdf, p. 109-110, citando Foucault, 1976, p. 193).

6. Análise crítica: por que o problema se produz e se mantém

O roteiro exige evitar explicações individualizantes. As fontes convergem em identificar pelo menos cinco fatores estruturais, não individuais, que produzem e sustentam a medicalização da infância:

1) A escola terceiriza seus próprios problemas pedagógicos

Ao atribuir uma dificuldade de aprendizagem a um transtorno neurológico, a escola isenta de responsabilidade "todas as outras instâncias implicadas", retornando à culpabilização do estudante (Fonte: 01_Dialogos_Medicalizacao.pdf, p. 3). Um estudo com três Conselhos Tutelares do Paraná mostrou que são as próprias escolas — e não as famílias — que acionam esse órgão de proteção para agilizar consultas com neurologistas e psiquiatras, transformando-o em "mais um instrumento no processo medicalizante" (Fonte: 04_Medicalizacao_Fracasso_Escolar.pdf, p. 1, 9-10). Uma conselheira entrevistada resume o mecanismo: "se for olhar pelas queixas das escolas, acho que a maioria das crianças 'taria' medicada, porque sempre é do mau comportamento" (Fonte: 04_Medicalizacao_Fracasso_Escolar.pdf, p. 10).

2) Classe social e racismo estrutural moldam quem é patologizado

A patologização de hoje tem raiz direta na patologização de classe de décadas passadas: culturas populares foram primeiro lidas como "inferiores", depois como produtoras de crianças com "atraso", até a explicação migrar para o terreno biológico (Fonte: 03_Infancia_Patologizacao_Nao_Aprendizagem.pdf, p. 2). Famílias pobres são frequentemente rotuladas de "negligentes" quando não conseguem manter a rotina de medicação exigida pela escola e pelo serviço de saúde — um rótulo que pode, na verdade, funcionar como mecanismo de controle da infância pobre historicamente marginalizada, e não como proteção genuína (Fonte: 04_Medicalizacao_Fracasso_Escolar.pdf, p. 11-12).

3) Conflito de interesse econômico na produção do próprio saber diagnóstico

Como já apontado na fundamentação teórica, boa parte das pesquisas que sustentam bases biológicas para o TDAH é financiada pelos laboratórios que fabricam os medicamentos correspondentes — "isso significa que são cerceadas por conflitos de interesses" (Fonte: 09_Medicalizacao_Educacao_Implicacoes.pdf, p. 746, nota 3). Esse não é um problema de má-fé individual de um médico, mas um desenho estrutural de financiamento da ciência.

4) Precarização da escola pública e da formação docente

A precariedade das escolas públicas brasileiras — má formação e remuneração dos professores, falta de recursos materiais e humanos, contradições nos programas do MEC (Fonte: 04_Medicalizacao_Fracasso_Escolar.pdf, p. 12) — é nomeada explicitamente como fator estrutural de produção do fracasso escolar que depois é lido, de forma invertida, como problema do aluno. Não se trata de culpar individualmente o professor: evidencia-se, antes, que a sociedade não valoriza formação profissional embasada em fundamentos críticos mais aprofundados (Fonte: 04_Medicalizacao_Fracasso_Escolar.pdf, p. 11, citando Silva & Leonardo, 2012).

5) Uma cultura mais ampla de performance e de individualização neoliberal

Em uma cultura em que "a obsessão de ganhar, de vencer, ser alguém" se tornou norma de conduta de massa (Fonte: 07_Medicalizacao_Infancias_Cuidados_Medicamentos.pdf, p. 455, citando Ehrenberg, 2010), e em que problemas sociais são sistematicamente lidos como falhas individuais — a "psicologização da vida" (Fonte: 13_Bases_Teoricas_Medicalizacao_Tese_USP.pdf, p. 128) —, o diagnóstico biomédico funciona também como alívio moral: ele "oferece uma explicação e produz um sentido que alivia o fardo moral ao qual somos submetidos numa sociedade altamente individualizante" (Fonte: 08_Movimentos_Medicalizacao_Vida.pdf, p. 29, citando Caliman).

É importante registrar uma ressalva presente nas próprias fontes acadêmicas, para que a análise crítica não se torne, ela mesma, simplificadora: isso não significa negar que crianças de fato sofrem, nem que algumas requerem apoio clínico. O que está em questão é a construção de um

transtorno concebido à margem das práticas sociais que o produzem (Fonte: 09_Medicalizacao_Educacao_Implicacoes.pdf, p. 760).

7. Possibilidades de intervenção e enfrentamento

No âmbito da família e da escola

A cartilha do Conselho Federal de Psicologia recomenda que profissionais de educação não atribuam a dificuldade só ao aluno, mas trabalhem de forma coletiva (equipe gestora + professores), com projetos pedagógicos participativos e diversificação de estratégias de ensino (Fonte: CFP_CartilhaMedicalizacao_web-16.06.15.pdf, p. 24-28). Para profissionais de saúde, recomenda-se não ler o laudo escolar antes de formar impressão própria, investigar o contexto familiar e social antes de encaminhar, e evitar fechar diagnóstico de "distúrbio orgânico" sem compreender esse contexto (Fonte: CFP_CartilhaMedicalizacao_web-16.06.15.pdf, p. 28-39).

No âmbito das políticas públicas e da legislação

O Brasil já conta com base normativa explícita contra a excessiva medicalização infantil. A Resolução nº 177/2015 do CONANDA determina que a criança tem direito a "alternativas não medicalizantes" que envolvam família, profissionais e comunidade, e exige abordagem multiprofissional e intersetorial das questões de aprendizagem e comportamento (Fonte: Resolucao177Conanda.pdf, p. 2, Art. 2º-3º). Em 2018, o Ministério Público Federal recomendou formalmente que o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais se abstivessem de regulamentar um dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente que exigiria triagem obrigatória de "risco psíquico" em todas as crianças de 0 a 18 meses — recomendação feita após o próprio Conselho Federal de Psicologia alertar para o "conceito equívoco de risco psíquico" embutido na norma (Fonte: recomendacao.pdf, p. 2, 9). O MPF citou estudos internacionais (Reino Unido, Austrália, Estados Unidos) que desaconselham a triagem universal de risco psíquico em bebês por falta de evidência científica suficiente (Fonte: recomendacao.pdf, p. 5-6).

No âmbito da atuação da Psicologia

A especificidade da contribuição da Psicologia na Educação está na mediação entre os aspectos que constituem a vida humana e os processos educacionais, garantindo a apropriação dos saberes acumulados historicamente — e não na aplicação de um "olhar clínico" individual sobre a criança (Fonte: Caderno_AF.pdf, p. 10). Entre as propostas concretas documentadas nas fontes estão: avaliação psicológica como processo de compreensão das relações escolares, e não apenas da criança isolada (Fonte: 02_Medicalizacao_Patologizacao_Educacao.pdf, p. 7); Planos Educacionais Individualizados construídos com professores, pais, psicólogos e, quando possível, a própria criança (Fonte: 14_Escola_Sofrimento_Critica_DSM.pdf, p. 93-94); e intervenções de psicologia escolar que criam espaço de fala para professores, pais e estudantes, revelando a complexidade das relações escolares em vez de localizar o problema em um único sujeito (Fonte: 01_Dialogos_Medicalizacao.pdf, p. 11).

Resgate do brincar e da experiência

No plano mais cotidiano, o resgate do brincar como forma legítima de elaboração de conflitos — "forma natural de comunicar, de recuperar o papel ativo, de se refazer e de formar seu eu" (Fonte: 05_Mapeando_Controversias.pdf, p. 11) — e de uma relação pedagógica centrada na experiência ("o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca", Fonte: 03_Infancia_Patologizacao_Nao_Aprendizagem.pdf, p. 7, citando Larrosa) aparecem como alternativas concretas, de baixo custo e sem efeitos colaterais, à resposta medicamentosa.

8. Assuntos quentes — controvérsias atuais sobre o tema

Lei nº 13.438/2017 e a triagem obrigatória de "risco psíquico" em bebês de 0 a 18 meses: incluída no Estatuto da Criança e do Adolescente, a norma segue sem regulamentação por recomendação expressa do Ministério Público Federal desde 2018, após o CFP alertar para o risco de ações iatrogênicas — falsos diagnósticos, excesso de intervenção e medicalização precoce (Fonte: recomendacao.pdf, p. 7, 9). É um caso raro em que a oposição à medicalização chegou ao nível de uma recomendação formal do Ministério Público contra a regulamentação de uma lei

federal já aprovada.

Conflitos de interesse na elaboração do DSM-5: a revelação de que cerca de 70% dos membros da força-tarefa do manual tinham vínculo financeiro com a indústria farmacêutica (Fonte: DSM E

TRANSTORNOS ASSOCIADOS À INFÂNCIA A CLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICA PSIQUIÁTRICA EM DISCUSSÃO.pdf, p. 6)

6) alimenta um debate público e acadêmico contínuo sobre a legitimidade científica dos critérios diagnósticos usados em todo o mundo, inclusive no Brasil.

A crise da saúde mental infantil nos Estados Unidos como alerta: segundo o ex-diretor do National Institute of Mental Health, os EUA registraram aumento de 30% nos suicídios entre 1990 e hoje (enquanto o mundo teve redução de 38%), gastaram mais de 200 bilhões de dólares por ano com saúde mental, e ficaram em 32º lugar entre 38 países ricos em bem-estar mental infantil, segundo a UNICEF (Fonte: DSM E TRANSTORNOS ASSOCIADOS À INFÂNCIA A CLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICA PSIQUIÁTRICA EM DISCUSSÃO.pdf, p. 11) — um dado usado por pesquisadores como evidência de que o aumento de diagnósticos e de prescrição medicamentosa não necessariamente traduz melhora efetiva na saúde mental da população infantil.

Movimentos de despatologização nas redes sociais e campanhas institucionais: desde o Manifesto do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade (mais de 2.300 assinaturas, Fonte: Caderno_AF.pdf, p. 16) até hashtags contemporâneas de desmedicalização (Fonte: 05_Mapeando_Controversias.pdf, p. 5), o tema segue mobilizando atores da sociedade civil, universidades e conselhos profissionais — mostrando que não se trata de um debate encerrado, mas de uma controvérsia ativa.

Judicialização e projetos de lei sobre dislexia e TDAH: um levantamento identificou 18 proposições legislativas entre 2003 e 2011, em diferentes esferas (Câmara Federal, Senado, Assembleia Legislativa de SP, Câmara Municipal de SP), tratando de dislexia e TDAH (Fonte: Caderno_AF.pdf, p. 8) — evidência de que a medicalização também avança por via legislativa, não apenas clínica ou escolar.

9. Síntese e resposta à pergunta norteadora

Pergunta norteadora do trabalho: "O que essa problemática revela sobre as condições em que o desenvolvimento humano acontece na sociedade contemporânea?"

A medicalização e a patologização da infância revelam, antes de tudo, que o desenvolvimento humano contemporâneo acontece sob vigilância permanente: a criança de hoje é continuamente observada, comparada a normas estatísticas e institucionais, e tem seu comportamento interpretado por adultos que raramente são chamados a examinar sua própria parte na produção daquilo que classificam como "problema" (Fonte: 09_Medicalizacao_Educacao_Implicacoes.pdf, p. 756, sobre a escola como "aparelho de exame ininterrupto", citando Foucault). Isso mostra que o desenvolvimento infantil, longe de ser um processo privado e estritamente biológico, acontece dentro de instituições — escola, família, saúde — que carregam interesses, limitações e históricos próprios, e que frequentemente resolvem suas próprias insuficiências transferindo o problema para dentro do corpo da criança.

Revela também que esse desenvolvimento acontece dentro de uma economia concreta: a segunda maior indústria do mundo em faturamento tem interesse direto em que mais crianças sejam diagnosticadas e medicadas (Fonte: Caderno_AF.pdf, p. 5), e boa parte do conhecimento científico que sustenta esses diagnósticos é produzida sob conflito de interesse (Fonte: DSM E TRANSTORNOS ASSOCIADOS À INFÂNCIA A CLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICA PSIQUIÁTRICA EM DISCUSSÃO.pdf, p. 6). O desenvolvimento humano, nesse sentido, não é hoje regulado apenas por pais, professores e profissionais de saúde agindo de boa-fé — é também, estruturalmente, um mercado.

Por fim, a problemática revela uma sociedade que tende a tratar a diferença — de ritmo, de comportamento, de origem social — como desvio a ser corrigido, em vez de como parte esperada da diversidade do desenvolvimento humano. A alternativa que as próprias fontes apontam não é negar que crianças sofrem ou negam o papel da saúde, mas devolver à análise a complexidade social, histórica, cultural e institucional que o diagnóstico biomédico isolado tende a apagar (Fonte: 09_Medicalizacao_Educacao_Implicacoes.pdf, p. 760) — e, com isso, devolver à criança o estatuto

de sujeito em desenvolvimento dentro de uma rede de relações, e não de paciente a ser ajustado por um transtorno.

10. Referências (fontes utilizadas nesta apostila)

- ATUMANE, A. M. A. Michel Foucault e Ivan Illich: análise crítica à medicalização da vida e do corpo. [SYN]THESIS, v. 12, n. 1, p. 98-107, 2019. (15_Foucault_Illich_Biopolitica.pdf)
- AZEVEDO, L. J. C. de. Medicalização das infâncias: entre os cuidados e os medicamentos. Psicologia USP, v. 29, n. 3, p. 451-458, 2018. (07_Medicalizacao_Infancias_Cuidados_Medicamentos.pdf)
- BARBOSA, M. de B.; LEITE, C. D. P. Infância e patologização: contornos sobre a questão da não aprendizagem. Psicologia Escolar e Educacional, v. 24, e220707, 2020. (03_Infancia_Patologizacao_Nao_Aprendizagem.pdf)
- BARBOSA, S. A. Mapeando as controvérsias que envolvem o processo de medicalização da infância. Psicologia & Sociedade, v. 31, e213211, 2019. (05_Mapeando_Controversias.pdf)
- BELTRAME, R. L.; GESSER, M.; SOUZA, S. V. de. Diálogos sobre medicalização da infância e educação: uma revisão de literatura. Psicologia em Estudo, v. 24, e42566, 2019. (01_Dialogos_Medicalizacao.pdf)
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA / Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. Recomendações de práticas não medicalizantes para profissionais e serviços de educação e saúde. São Paulo, 2015. (CFP_CartilhaMedicalizacao_web-16.06.15.pdf)
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Subsídios para a Campanha Não à Medicalização da Vida. XV Plenário, Gestão 2011-2013. (Caderno_AF.pdf)
- CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). Resolução nº 177, de 11 de dezembro de 2015. (Resoluo177Conanda.pdf)
- FIGUEIRA, P. L.; CALIMAN, L. V. Considerações sobre os movimentos de medicalização da vida. Psicologia Clínica, v. 26, n. 2, p. 17-32, 2014. (08_Movimentos_Medicalizacao_Vida.pdf)
- MINAKAWA, M. M. Bases teóricas dos processos de medicalização: um olhar sobre as forças motrizes. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) — USP, 2016. (13_Bases_Teoricas_Medicalizacao_Tese_USP.pdf)
- MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL — PRDF. Recomendação GAB-LLO/PRDF nº 01/2018. Brasília, 10 jan. 2018. (recomendacao.pdf)
- PERUZZOLO, M. C.; VIARO, R. V. DSM e transtornos associados à infância: a classificação diagnóstica psiquiátrica em discussão. 2024. (DSM E TRANSTORNOS ASSOCIADOS À INFÂNCIA A CLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICA PSIQUIÁTRICA EM DISCUSSÃO.pdf)
- SCARIN, A. C. C. F.; SOUZA, M. P. R. de. Medicalização e patologização da educação: desafios à Psicologia Escolar e Educacional. Psicologia Escolar e Educacional, v. 24, e214158, 2020. (02_Medicalizacao_Patologizacao_Educacao.pdf)
- SCHOENBERGER, F.; CHAMPAGNATTE, D. M. de O. Escola e sofrimento psíquico infantil: crítica ao DSM e caminhos para uma prática pedagógica inclusiva. p. 80-97. (14_Escola_Sofrimento_Critica_DSM.pdf)
- SIGNOR, R. de C. F.; BERBERIAN, A. P.; SANTANA, A. P. A medicalização da educação: implicações para a constituição do sujeito/aprendiz. Educação e Pesquisa, v. 43, n. 3, p. 743-763, 2017. (09_Medicalizacao_Educacao_Implicacoes.pdf)
- TABET, L. P. et al. Ivan Illich: da expropriação à desmedicalização da saúde. Saúde em Debate, v. 41, n. 115, p. 1187-1198, 2017. (Ivan Illich da expropriação à desmedicalização da saúde.pdf)
- TAVERNA, C. S. R. [Resenha] Medicalização de Crianças e Adolescentes. Revista da ABRAPEE, v. 15, n. 1, p. 169-171, 2011. (06_Medicalizacao_Crianças_Adolescentes.pdf)
- WERLANG, E. M.; PEREIRA, D. P.; BETT, G. de C. Medicalização da infância, fracasso escolar e Conselho Tutelar: uma análise histórico-cultural. Psicologia em Estudo, v. 29, e55625, 2024. (04_Medicalizacao_Fracasso_Escolar.pdf)
- Roteiro do Trabalho Avaliativo — Psicologia do Desenvolvimento Humano (documento-base da

disciplina). (Roteiro_Trabalho_Psicologia_Desenvolvimento_Humano_45_alunos.pdf)